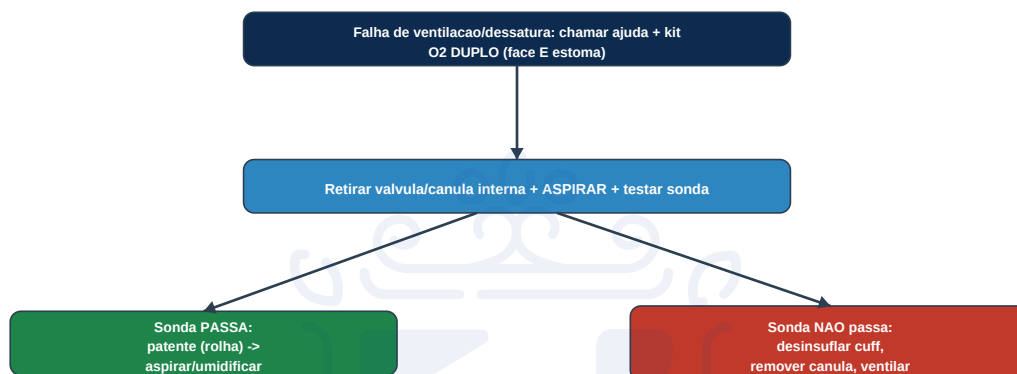


TRAQUEOSTOMIA — OBSTRUÍDA x DESLOCADA

FLUXOGRAMA — VIA AÉREA EM RISCO

TRAQUEO — OXIGENAR, DESOBSTRUIR, VENTILAR



PONTO-CHAVE — TRAQUEOSTOMIA x LARINGECTOMIA

DEFINIR ANTES DE TUDO

- TRAQUEOSTOMIA: a via aérea superior geralmente ainda existe -> pode-se ventilar por boca/nariz e até intubar pela boca
- LARINGECTOMIA TOTAL (estoma terminal): NÃO ventila por boca/nariz — a via aérea é SOMENTE pelo pescoço
- Perguntar ao paciente/família/prontuário qual é o caso muda toda a conduta
- Tempo da traqueostomia: < 7 dias = estoma NÃO maduro (alto risco de falso trajeto ao recolocar)
- Saber: depende de ventilador? tipo/tamanho da cânula? tem cuff? fenestrada? tem cânula interna?

CAUSAS PRINCIPAIS

Complicação	Características
Obstrução	Rolha de muco, secreção espessa, coágulo (a mais comum)
Deslocamento/decanulação	Cânula parcial/totalmente fora, FALSO TRAJETO (sobretudo traqueostomia recente)
Problema do cuff	Vazamento/ruptura (VM difícil); cuff muito cheio (isquemia)
Sangramento	Trauma/aspiração; catastrófico: FÍSTULA TRAQUEO-INOMINADA (pode iniciar como 'sangramento sentinela')
Outras	Infecção/dermatite do estoma, granuloma; pós-troca recente: enfisema subcutâneo, pneumotórax

PACIENTE INSTÁVEL — ALGORITMO

Rx NÃO VENTILA / DESSATURA

Passo 0: chamar ajuda (anestesia/cirurgia) + trazer o KIT (aspirador, ambu, O₂, máscaras, cânula igual + uma menor, seringa do cuff, xilo gel)

Passo 1: O₂ DUPLO — alto fluxo na FACE E no ESTOMA enquanto decide

Passo 2: remover válvula de fala/conector + RETIRAR a cânula interna e limpar/trocar; ASPIRAR

Passo 3: testar patência com sonda — PASSA facilmente = patente (rolha parcial: aspirar, umidificar, nebulizar SF); NÃO passa = obstrução completa/deslocamento (emergência de via aérea)

Passo 4: desinsuflar o CUFF e reavaliar (pode permitir ventilação pela via aérea superior)

Passo 5-6: remover a cânula bloqueada; ventilar pelo caminho certo — traqueostomia: ambu por boca/nariz OCLUINDO o estoma; laringectomia: ventilar SÓ pelo estoma (máscara pediátrica veda melhor)

RECOLOCAR A CÂNULA? DEPENDE DO ESTOMA

Rx MADURO x RECENTE

Estoma MADURO (> 7-10 dias, crônico): tentar recolocar mesmo tamanho; se difícil, uma menor; usar obturador, lubrificar, técnica suave

Confirmar com CAPNOGRAFIA + expansibilidade + ausculta antes de fixar

DICA: se difícil recolocar a cânula, introduzir um tubo orotraqueal fino (5,5/6,0/6,5, aramado se disponível) pelo traqueostoma — cuidado para não seletivar

Estoma RECENTE (< 7 dias) ou tempo desconhecido: EVITAR tentativas cegas repetidas (alto risco de falso trajeto) — priorizar ventilação por face e INTUBAÇÃO orotraqueal

Capnografia é o melhor 'detector de via aérea' quando o paciente ventila

SANGRAMENTO — FÍSTULA TRAQUEO-INOMINADA

EMERGÊNCIA RARA E LETAL

- Sangramento pequeno e paciente bem: aspirar, avaliar trauma local, umidificar, revisar anticoagulação, observar (comum pós-aspiração)
- Sangramento moderado/grande OU 'do nada': suspeitar de FÍSTULA TRAQUEO-INOMINADA (mortalidade altíssima)
- Contenção (ponte até a cirurgia): HIPERINSUFLAR o cuff para tamponar
- Se falhar: COMPRESSÃO DIGITAL via estoma contra a parede anterior — a artéria inominada é ANTERIOR à traqueia, então comprimir em direção ao ESTERNO (não à coluna)
- Acionar CIRURGIA URGENTE imediatamente

PACIENTE ESTÁVEL, INTERNAÇÃO E CASA

CONDUTAS

- ☐ Estável (apito/vazamento/obstrução parcial): retirar válvula/tampão, limpar a cânula interna, aspirar, umidificar; checar circuito/cuff se em VM; nebulização com SF se secreção espessa
- ☐ Estoma com celulite: higiene local, cultura se secreção purulenta, antibiótico conforme gravidade
- ☐ INTERNAR/observar em sala de emergência: hipoxemia/desconforto, via aérea não confirmada, traqueostomia recente com complicação, sangramento importante/suspeita de fístula, pneumotórax/enfisema pós-troca, necessidade de broncoscopia/cirurgia
- ☐ ALTA se: ventila bem, SpO₂ basal, cânula patente e fixada, causa resolvida, sem sangramento, família orientada
- ☐ Casa: nebulização com SF 5 mL 4-6/6h se secreção, umidificação/hidratação, aspiração só se necessário, sinais de alarme ('não entra ar', sonda não passa, dessaturação, sangramento, febre)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Via aérea: () traqueostomia () laringectomia total; tempo da traqueo ____ dias (última troca ____); cânula tamanho ____, cuffada? interna?
- Dependência de VM ____; gatilho: obstrução/decanulação/sangramento/vazamento; SpO2 ____, necessidade de O2 ____.
- Achados: sonda de aspiração (passa/não passa), secreção espessa, enfisema subcutâneo, sangramento; condutas: retirada de cânula interna, aspiração, desinsuflar cuff, troca/remoção, ventilação por face/estoma.
- Solicito via aérea estável + broncoscopia/cirurgia se sangramento importante/fístula ou complicação pós-troca; UTI se instável.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Por que é fundamental diferenciar traqueostomia de laringectomia total na emergência de via aérea?

- A) Não há diferença prática
- B) Na traqueostomia ainda se pode ventilar por boca/nariz; na laringectomia total a via aérea é SOMENTE pelo estoma cervical
- C) A laringectomia permite intubação oral
- D) A traqueostomia nunca tem cuff
- E) São a mesma coisa

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Diante de cânula de traqueostomia possivelmente obstruída, qual passo confirma a patência?

- A) Radiografia de tórax
- B) Tentar passar uma sonda de aspiração: se passa facilmente, está patente
- C) Inserir contraste
- D) Apenas auscultar
- E) Trocar a cânula às cegas

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Traqueostomia recente (< 7 dias) com decanulação e dificuldade de recolocar a cânula. Qual a conduta mais segura?

- A) Tentativas cegas repetidas de recolocação
- B) Evitar tentativas cegas (risco de falso trajeto); priorizar ventilação por face e intubação orotraqueal
- C) Aguardar sem fazer nada
- D) Forçar a cânula maior
- E) Apenas O2 no estoma

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sangramento volumoso e súbito pela traqueostomia. Qual a manobra de contenção até a cirurgia?

- A) Clampear a cânula
- B) Hiperinsuflar o cuff para tamponar e, se falhar, compressão digital via estoma em direção ao esterno (fístula traqueo-inominada)
- C) Aspirar vigorosamente
- D) Retirar a cânula e observar
- E) Comprimir em direção à coluna

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o melhor 'detector de via aérea' para confirmar ventilação após manejo da traqueostomia?

- A) Oximetria isolada
- B) Capnografia (associada a expansibilidade e ausculta)
- C) Frequência cardíaca
- D) Temperatura
- E) Glicemia capilar

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Na traqueostomia a via aérea superior costuma estar pérvia (ventila-se por boca/nariz e pode-se intubar); na laringectomia total a via aérea é exclusivamente pelo estoma cervical — isso define a estratégia de ventilação.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Passar uma sonda de aspiração testa a patência: se passa facilmente, a cânula está pérvia (provável rolha parcial); se não passa, pensar em obstrução completa ou deslocamento.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na traqueostomia recente (estoma não maduro), tentativas cegas de recolocação têm alto risco de falso trajeto; prioriza-se ventilação por face e intubação orotraqueal.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

No sangramento volumoso suspeita-se de fístula traqueo-inominada: hiperinsuflar o cuff para tamponar e, se falhar, compressão digital via estoma contra a parede anterior em direção ao esterno (a artéria é anterior), acionando cirurgia urgente.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A capnografia é o melhor detector de via aérea quando o paciente ventila, complementada por expansibilidade torácica e ausculta.

SM24
Suporte ao Plantão Médico